ПРИКАЗЫ И ПИСЬМА В ИЗЛОЖЕНИИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Энтеровирусные инфекции

Коксаки и ECHO: клинические формы, показания к эвакуации в инфекционный стационар и меры гигиены при работе с больными

Источник: информационное письмо ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы № 1-14/2821 от 15.08.2023.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 11 октября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

О чём письмо

Письмо издано по приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 31.07.2023 № 791, которым предписаны дополнительные мероприятия по недопущению завоза и распространения на территории Москвы энтеровирусной (неполио) инфекции в 2023–2024 годах.

В отличие от писем о конвенционных инфекциях, операционное содержание здесь иное: **решение бригады — не режим санитарной охраны, а маршрутизация. Часть форм лечится на дому; обязательной эвакуации в инфекционный стационар подлежат подозрение на поражение ЦНС или сердца, выраженная интоксикация, обезвоживание и неблагоприятные эпидемиологические данные.**

Энтеровирусные инфекции как группа болезней

Энтеровирусные инфекции — группа острых антропонозных заболеваний, вызываемых вирусами групп Коксаки и ECHO; характерны интоксикационный синдром и полиморфизм проявлений с множественным поражением центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, мышц, кожи и слизистых. Клиническая картина не позволяет дифференцировать инфекцию вирусами Коксаки от ECHO, поэтому клинический диагноз формулируется как «энтеровирусная инфекция».

К энтеровирусам относятся вирусы Коксаки А (24 серовара), Коксаки В (6 сероваров) и ECHO (34 серовара). Они устойчивы во внешней среде: до 2 месяцев сохраняются в сточных водах и открытых водоёмах, переносят замораживание, устойчивы к 70 % спирту; быстро погибают под действием перманганата калия, перекиси водорода и при кипячении. Присутствие органических веществ в воде инактивирует хлорсодержащие дезинфектанты, чем объясняется обнаружение энтеровирусов в водопроводной воде.

Источник инфекции — больной человек или вирусоноситель; значимая роль в распространении принадлежит реконвалесцентам и контактным лицам. Механизм передачи фекально-оральный; пути — водный, алиментарный, контактно-бытовой, не исключается воздушно-капельный; возможна трансплацентарная передача. Заболеваемость круглогодичная, в странах умеренного климата отмечаются летне-осенние подъёмы и вспышки.

Клинические формы

Типичные формы: герпангина, эпидемическая миалгия, серозный менингит, экзантема. Атипичные: инаппарантная, малая болезнь («летний грипп»), паралитическая, энцефалит, энцефаломиокардит новорождённых, эпидемический геморрагический конъюнктивит, увеит, нефрит, панкреатит.

Форма	Клиническая характеристика
Герпангина	Острое начало, высокая лихорадка 1–5 дней при умеренной интоксикации. В первые 2 суток — боли в горле, гиперемия и мелкие папулы на мягком нёбе, дужках, язычке и задней стенке глотки; папулы превращаются в везикулы с серозным содержимым, через 12–24 часа вскрываются с образованием эрозий с сероватым налётом; эрозии сливаются в язвы 7–10 мм с венчиком гиперемии и эпителизируются за 4–6 дней. Возможно рецидивирующее течение и развитие на фоне серозного менингита

Форма	Клиническая характеристика
Эпидемическая миалгия	Острое начало: озноб, температура 39–40 °C, сильная головная боль и мышечные боли в груди, усиливающиеся при малейших движениях и кашле; тошнота, рвота, гиперемия зева, увеличение шейных лимфоузлов. Миалгии обусловлены миозитом и могут симулировать острую патологию брюшной полости, плеврит и пневмонию. Длительность 3–7 дней, возможны 2–3 волны боли с интервалом 2–4 дня
Серозный менингит	Одна из наиболее тяжёлых форм. Начало подострое или острое; сильная головная боль, гиперакузия, фотофобия, рвота без облегчения, общемозговой и менингеальный синдромы (возможен неполный синдром: ригидность затылочных мышц без симптома Кернига и наоборот). При тяжёлом течении — психомоторное возбуждение и судороги. Неврологическая симптоматика с первых суток или с 3–5-го дня; лихорадка и менингеальный синдром около недели, затем астения, изредка длительный субфебрилитет
Энтеровирусная экзантема	Пятнисто-папулёзная, краснухоподобная, реже петехиальная сыпь на лице, туловище и конечностях на фоне острой высокой лихорадки и интоксикации; возможны боль в горле, пятнистая энантема ротоглотки, фарингит, конъюнктивит, увеличение шейных лимфоузлов; у части больных сыпь локализуется ограниченно
Малая болезнь («летний грипп»)	Кратковременная (около 3 дней) лихорадка со слабостью, головной болью, миалгиями и болью в животе; возможно двухволновое течение
Энтеровирусная диарея	Преимущественно у детей: лихорадка, интоксикация, вздутие живота, многократная рвота, жидкий стул 2–10 раз в сутки без примесей, катаральные явления; длительность от 2 дней до 2 недель
Паралитическая форма	Чаще у детей: на фоне субфебрильной или нормальной температуры — парезы нижних конечностей («утренняя хромота»), нарушение походки, ротация ноги кнаружи, снижение мышечного тонуса; парезы проходят быстро
Энцефаломиокардит новорождённых	Анорексия, сонливость, рвота, диарея, цианоз, одышка, тахикардия, расширение границ сердца, глухость тонов, аритмия, отёки, гепатоспленомегалия, серозный менингит
Эпидемический геморрагический конъюнктивит	Острое начало с одного глаза и переходом на второй за 1–2 дня: ощущение инородного тела, слезотечение, фотофобия, отёк век, гиперемия и кровоизлияния конъюнктивы; выздоровление за 1,5–2 недели
Перикардит и миокардит	После катаральных явлений или остро: умеренная лихорадка, резкая слабость, боли в области сердца, расширение границ, глухость тонов, шум трения перикарда; течение обычно доброкачественное

Экзантема и энантема

Наиболее узнаваемый вариант энтеровирусной экзантемы — синдром «рука — нога — рот» (вирусный пузырчатый стоматит с экзантемой), вызываемый преимущественно вирусами Коксаки A16, A6 и энтеровирусом A71. Он отдельно в письме не назван, но относится к описанной в нём экзантемной форме. На фоне лихорадки появляются болезненные везикулы и эрозии на слизистой полости рта и мелкие папулы и везикулы с венчиком гиперемии на ладонях, подошвах, боковых поверхностях пальцев, реже на ягодицах (рис. 1). Элементы не зудят, разрешаются без рубцов за 7–10 дней; через 1–2 месяца возможна десквамация кожи пальцев и отслоение ногтевых пластин. Заболевание чаще встречается у детей младше 5 лет, но возникает и у взрослых.

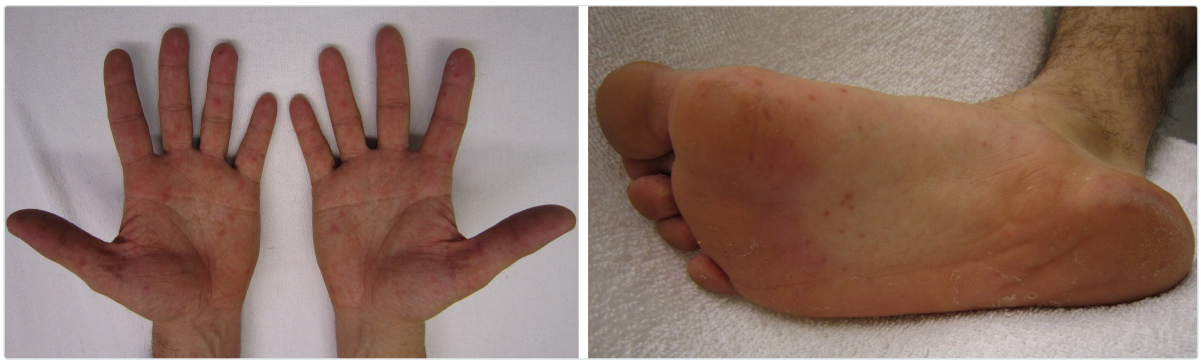


Рис. 1. Экзантема при синдроме «рука — нога — рот» у взрослого: мелкие красные пятна, папулы и везикулы на ладонных поверхностях кистей и пальцев (слева) и на подошве (справа). Фото: James Heilman, MD, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Энантема при герпангине располагается на мягком нёбе, нёбных дужках, язычке и задней стенке глотки: на гиперемированной слизистой видны папулы и везикулы, затем эрозии и язвы с сероватым налётом и венчиком гиперемии (рис. 2). В отличие от герпетического стоматита, при герпангине не поражаются дёсны и передние отделы полости рта; в отличие от ангины, налёты на миндалинах отсутствуют.



Рис. 2. Герпангина: гиперемия мягкого нёба, отёк язычка, эрозии и язвы с беловатым налётом на язычке и нёбных дужках. Фото: Klaus D. Peter, Wikimedia Commons, CC BY 3.0 DE.

Диагностика и лечение

Клинический диагноз устанавливается при типичном течении; лабораторно применяются серологические методы (РСК, РТГА), наиболее ранним и точным является ПЦР. Специфического лечения и профилактики на момент письма не разработано: применяются патогенетические и симптоматические средства — дезинтоксикация, пероральная регидратация, жаропонижающие.

Тактика на догоспитальном этапе

Больные с герпангиной, экзантемой, эпидемической миалгией, эпидемическим геморрагическим конъюнктивитом, «летним гриппом» и энтеровирусной диареей могут лечиться на дому.

Обязательной медицинской эвакуации в инфекционный стационар подлежат:

- подозрение на поражение центральной нервной системы или сердца;
- выраженный интоксикационный синдром;

- обезвоживание;
- неблагоприятные эпидемиологические данные — нахождение больного в закрытых коллективах, общежитиях и т. п.

При работе с больными используются одноразовые маски и резиновые перчатки; после работы — тщательное мытьё рук с обработкой кожным антисептиком; после аускультации фонендоскоп протирается спиртовыми салфетками.

Предписания письма

- Письмо доводится до выездного персонала под роспись и размещается на образовательном портале Станции.
- Заведующим предписано проведение занятий с персоналом по эпидемиологии, клинике, лечению и тактике энтеровирусных инфекций.
- Выездному персоналу — изучить письмо на портале и проявлять повышенную настороженность при оказании помощи лихорадящим больным.

Источники

- Информационное письмо ГБУЗ «ССиНМП им. А. С. Пучкова» ДЗМ № 1-14/2821 от 15.08.2023.
- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 31.07.2023 № 791.
- Esposito S., Principi N. Hand, foot and mouth disease: current knowledge on clinical manifestations, epidemiology, aetiology and prevention. *European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases*, 2018; 37(3): 391–398 — возбудители, клиническая картина, поздняя десквамация и онихомадезис.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
`images/ekzantema_kisti_stopy.jpg`	Экзантема при синдроме «рука — нога — рот»: кисти и подошва	Wikimedia Commons, «Characteristic rash of hand, foot, and mouth disease, on human hands.jpg» и «… on a human foot.jpg», автор James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0; компоновка — проект
`images/gerpangina.jpg`	Герпангина	Wikimedia Commons, «Herpangina.jpg», автор Klaus D. Peter, CC BY 3.0 DE

Выходные данные

Энтеровирусные инфекции · версия 1.1 · октябрь 2026 · Серия «Крещение поворотом» ·

CC BY-NC-SA 4.0. Материал носит справочный характер и не заменяет действующие приказы и клинические рекомендации.

Нашли ошибку — напишите в «Обсуждениях» репозитория на GitHub.